

BDD a inne zaburzenia

BDD współistnieje lub przypomina inne zaburzenia: OCD, anoreksję, depresję, fobię społeczną. Karta pomaga rozróżnić — i rozpoznać, kiedy potrzebne jest leczenie kilku problemów równolegle.

CZAS: 15 min — przeczytanie Pomoc w rozumieniu diagnozy

ŹRÓDŁO: Phillips (2009); Wilhelm (2013); DSM-5-TR (2022)

JAK UŻYWAĆ

BDD **współistnieje** z innymi zaburzeniami u *większości pacjentów*: depresja (75%), fobia społeczna (37%), OCD (32%), zaburzenia odżywiania (20–30%). To **nie znaczy**, że BDD jest „częścią” tych zaburzeń. BDD ma własne kryteria, własną patofizjologię, własne leczenie. Trzy typowe pomyłki diagnostyczne: **1)** BDD diagnozowane jako OCD (i leczone tylko OCD), **2)** BDD diagnozowane jako anoreksja (gdy dotyczy masy ciała / sylwetki), **3)** BDD niediagnozowane wcale, leczona tylko depresja. Karta zawiera kryteria różnicujące: jak rozpoznać, czy to BDD, czy inne zaburzenie, czy oba równolegle.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Phillips (2009) opisała, że **80% pacjentów z BDD** zostaje wstępnie błędnie zdiagnozowanych — najczęściej jako fobia społeczna (35%), depresja (25%), OCD (20%). To opóźnia *specyficzne leczenie BDD*. Mechanizm pomyłki: BDD ma elementy wszystkich tych zaburzeń (intruzje jak w OCD, lęk społeczny jak w fobii, obniżony nastrój jak w depresji), ale **treść jest specyficzna**: zawsze dotyczy wyglądu fizycznego i konkretnej części ciała. Wilhelm (2013): „*jeśli pacjent ma intruzje dotyczące skóry, sprawdza ją kompulsywnie, unika ludzi z powodu obawy, że zobaczą — to nie jest OCD ani fobia społeczna ani depresja. To BDD*”. Diagnoza BDD nie wyklucza innych — często są *równolegle* i wymagają zintegrowanego leczenia.

01

BDD vs OCD

WSPÓLNE

- Intruzywne myśli
- Rytuały (sprawdzanie, czyszczenie)
- Próba „kontrol” przez powtarzanie
- Wgląd zmienny
- Odpowiedź na SSRI w wyższych dawkach

CO ODRÓŻNIA

- **BDD:** treść zawsze dotyczy wyglądu
- **OCD:** różne treści (czystość, agresja, kolejność)
- **BDD:** słabszy wgląd (30–40% z urojeniami)
- **OCD:** zwykle dobry wgląd
- **BDD:** więcej myśli samobójczych (80% vs 50% OCD)

02

BDD vs anoreksja / zaburzenia odżywiania

WSPÓLNE

- Zaburzony obraz ciała
- Sprawdzanie w lustrze
- Porównania społeczne
- Wstyd, izolacja

CO ODRÓŻNIA

- **Anoreksja:** centrum to masa ciała + restrykcja jedzenia + niska waga
- **BDD:** centrum to konkretna część ciała (skóra, nos), niekoniecznie waga
- **BDD muscle dysmorphia:** mężczyźni, „za mało mięśni”, trening + sterydy
- **Reguła DSM-5-TR:** jeśli centrum to masa/tłuszcz — anoreksja; jeśli inna część — BDD

WSPÓLNE

- Unikanie sytuacji społecznych
- Lęk przed oceną
- Wycofanie z relacji
- Skupienie na sobie w sytuacjach społecznych

CO ODRÓŻNIA

- **Fobia społeczna:** lęk przed oceną zachowania, słów, wystąpień
- **BDD:** lęk przed oceną *wyglądu* — konkretna część ciała
- **BDD:** rytuały kosmetyczne, kamuflaż, sprawdzanie w lustrze
- **BDD:** niemożność wyjścia bez warstwy makijażu/ubrań

WSPÓLNE

- Niskie poczucie własnej wartości
- Myśli samobójcze
- Wycofanie z aktywności
- Trudność z pracą i relacjami
- Często współistnieją

CO ODRÓŻNIA

- **BDD:** intruzje skoncentrowane na wyglądzie
- **BDD:** konkretne rytuały sprawdzania
- **Depresja:** generalizowane obniżenie nastroju, anhedonia
- **BDD bez depresji:** zachowana zdolność do radości w sytuacjach, w których wygląd nie jest centrum

● Implikacje praktyczne — co to znaczy dla terapii

1. Jeśli centrum problemu to *konkretna część ciała* (skóra, nos, włosy, sylwetka) — proś o ocenę pod kątem BDD, nie tylko depresji lub fobii społecznej.
2. Jeśli leczysz się na OCD od lat bez wyraźnej poprawy, a obsesje dotyczą wyglądu — możliwe, że to BDD, które wymaga *protokołu specyficznego dla BDD* (CBT-BDD Wilhelm 2013), nie standardowego ERP dla OCD.
3. Jeśli walczysz z anoreksją, ale centrum to konkretna część ciała (np. nos, skóra) *poza* obawami o masę — dopytaj o ocenę BDD. Leczenie może wymagać dwóch protokołów równolegle.
4. Depresja często jest *wtórna* w BDD. Leczenie samej depresji bez BDD może dać krótkotrwałą ulgę, ale objawy wracają. *Zintegrowane podejście* daje trwałe wyniki.

Klucz: Wilhelm (2013): „specyficzność diagnozy ma kliniczne znaczenie. BDD wymaga terapii specyficznej dla BDD. Nie każdy terapeuta zna ten protokół — pytaj wprost o doświadczenie z BDD”. Jeśli leczysz się od lat bez wyraźnej zmiany, warto rozważyć drugą opinię diagnostyczną u kogoś znającego BDD. To *nie podważanie pierwszego specjalisty* — to korzystanie z prawa do najlepszej możliwej diagnozy.